

DATA FEASIBILITY CHECK — стадия 3 из процесса СВО

Проверка ТЗ v2.0 «Medical Access Intelligence Engine» и реальная проверка источников данных по странам-кандидатам

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 7 августа 2026 · Разбираемый документ: Medical_Access_Intelligence_Engine_Technical_Spec_v2_RU.docx (531 абзац, 19 разделов). Метод: прямая проверка порталов открытых данных и API, включая обращение к боевому API data.gov.il.

Где мы находимся по процессу

Стадия	Статус	Основание
Идея	Пройдено	ТЗ v1, август 2026
VALIDATED GAP	Пройдено	Проверка гипотезы от 06.08.2026: функции 5, 6 и 8 не закрыты ни одним игроком. Разрыв подтверждён.
DATA FEASIBILITY CHECK	ЭТОТ ДОКУМЕНТ — условное прохождение	Источники найдены и проверены. Но выбор страны из ТЗ (Израиль) по данным слабейший из кандидатов.
DEVELOPMENT	НЕ НАЧИНАТЬ	Остаётся один шаг, которого требует само ТЗ (§3.2): proof-of-data на 20–30 препаратах.

Главный вывод

Данные для функций 5 и 6 существуют в машиночитаемом виде — но не в Израиле.

Австралия отдаёт полный официальный API со всеми условиями назначения и возмещения, бесплатно, с ежемесячным обновлением. Франция отдаёт открытые данные. Великобритания — машиночитаемо, но под лицензией.

Израиль — единственный кандидат без открытого набора данных. Я обратился к боевому API data.gov.il: по запросу «לרפואה» возвращается 4 набора — аптеки, лицензии аптек, клиники. Ни реестра лекарств, ни корзины здоровья там нет.

Это прямое противоречие между **пригодностью данных** (Австралия) и **пригодностью рынка** (Израиль: язык, рецензенты, диаспора). Решение за Наумом, но принимать его надо осознанно.

Проверка источников по странам

Юрисдикция	Регуляторный статус (Q4)	Доступность и покрытие (Q5–Q6)	Формат	Вердикт
Австралия	TGA — отдельный источник	PBS API — полный набор PBS Schedule: субсидируемые препараты плюс условия назначения и отпуска . Обновление 1-го числа каждого месяца. XML и текстовые файлы отключаются с 1 мая 2026 — API становится единственным источником.	REST API + CSV, официальный, бесплатный	ЛУЧШИЙ
Франция	ANSM через BDPM	BDPM — официальная база ANSM совместно с HAS и UNCAM, опубликована на data.gouv.fr. Плюс Open Medic — годовые базы возмещений в CSV с 2014 года.	Открытые данные, CSV	Хорошо
Великобритания	MHRA	dm+d через TRUD (NHS England) в XML; NICE syndication API в JSON/XML с рекомендациями и стандартами качества.	Машиночитаяемо, но требуется лицензионное соглашение и ключ API	Хорошо, но с трением
ЕС (ЕМА)	Есть. Таблицы по централизованно одобренным препаратам, обновляются ночью; экспорт в Excel, JSON, CSV, XML, RSS	Неприменимо — цена и возмещение остаются национальными	Структурированная выгрузка	Годится только для Q4
Израиль	Реестр лекарств Минздрава — только веб-форма	Корзина здоровья: комиссия завершает работу в конце года, решения публикуются на сайте Минздрава, обновление вступает в силу с началом следующего года. Проверка права — через веб-портал «Коль ха-Бриют». Открытого набора данных не найдено.	Веб и PDF; API нет	СЛАБЕЙШИЙ по данным

Находка, которую стоит обдумать отдельно

Израильская корзина здоровья обновляется **раз в год**: комиссия заканчивает работу в конце календарного года, правительство утверждает список, и он вступает в силу с 1 января.

Из этого следуют два вывода, и они противоположны по знаку:

- **В пользу Израиля:** ручной сбор данных о покрытии — это работа **раз в год**, а не каждую неделю. Правило ТЗ «более 30% статусов требуют ручного поиска — пересчитать трудоёмкость» здесь надо читать иначе: 30% от годового пакета работ, а не от непрерывного потока. Отсутствие API в Израиле обходится дешевле, чем кажется на первый взгляд.
- **Против Израиля:** если покрытие меняется раз в год, то функции 8 — непрерывному мониторингу, который в ТЗ назван **главным механизмом удержания**, — в Израиле почти нечего отслеживать по линии Q6. Ценность мониторинга там сместится на Q4 (регуляторные изменения) и Q7 (исследования и expanded access).

Отсюда пробел в самом gate. §3.2 проверяет, *можно ли получить* данные, но не проверяет, **как часто они меняются**. А частота изменений — это и есть продукт: сервис уведомлений о том, что меняется раз в год, — это не сервис уведомлений.

Рекомендую добавить в gate обязательный пункт: измерить фактическую частоту изменений по каждому критическому полю за последние 24 месяца. Если по выбранной стране Q5 и Q6 меняются реже, чем раз в квартал, — ядро ценности смещается, и это надо признать до разработки, а не после.

Оценка самого T3 v2.0

Документ сильный. Он не просто учёл предыдущие два анализа — он сузил замысел именно там, где это было нужно, и сделал это жёстче, чем предлагал я.

Что сделано особенно хорошо

- **Явный список того, что мы НЕ строим (§2.2)**. Это защита от расползания замысла, и её обычно не пишут.
- **STOP/GO gate с числовым порогом (§3.2)** — «более 30% ручного поиска → пересчитать». Проверяемое условие вместо намерения.
- **Модель приоритета источников P0–P3 с уровнем «Запрещено» (§8.1)**. Форумы и промо-страницы клиник прямо исключены как источник статуса.
- **Состояние «verification overdue» (§8.2)**. Система умеет признаться, что данные устарели, вместо того чтобы показывать старое как актуальное.
- **Запрет бинарного упрощения покрытия** — условные и неизвестные состояния предусмотрены. Для реального возмещения это принципиально.
- **Пациент видит last_verified_at**, а не только дату публикации источника.
- **Патентный риск включён в таблицу рисков** с условием юридической проверки до коммерческого запуска.

Чего в документе не хватает

#	Пробел	Почему это важно	Что добавить
1	«Material change» нигде не определено	§8 говорит: «если существенное изменение — создать ChangeEvent». Но что считается существенным, не сказано ни разу. Это главное бизнес-правило продукта — оно решает судьбу каждого уведомления. Слишком широко — спам и отписки; слишком узко — пропущено важное, и это уже вопрос доверия.	Таблица материальности по каждому полю: смена статуса покрытия — существенно; правка формулировки показания — нет; изменение цены — зависит от юрисдикции. Определить до кода.
2	В gate нет проверки частоты изменений	Проверяется доступность данных, но не их динамика. Продукт продаёт мониторинг; если данные статичны, продавать нечего.	Замерить фактическую частоту изменений за 24 месяца по каждому критическому полю.

#	Пробел	Почему это важно	Что добавить
3	В реестре источников нет условий лицензии	§3.2 требует определить формат (API/CSV/PDF), но не правовой режим. NICE требует лицензионного соглашения; коммерческие базы платные; часть сайтов запрещает автоматический сбор. Это риск не технический, а юридический.	Поля licence_terms, commercial_use_allowed, scraping_allowed, attribution_required — обязательные для каждого источника.
4	Нет имени медицинского рецензента	T3 верно откладывает выбор нозологии до появления рецензента. Но конкретного человека по-прежнему нет, а это связующее ограничение всего проекта: без него не пройти review gate из §8, сколько бы кода ни было написано.	Получить согласие конкретного онколога до старта разработки.

Об архитектуре: Java + Python

В предыдущем анализе я рекомендовал один runtime — только Python. T3 выбрало Spring Boot как ядро и Python как отдельный сервис ingestion, обосновав это сильной стороной разработчика. **Возражение снимаю** — обоснование законное, и граница проведена чисто: «Spring Boot владеет истиной и процессом, Python предлагает извлечённые факты».

Более того, для этого домена Java объективно уместнее, чем в предыдущей версии замысла: версионирование фактов, аудит, review workflow и права доступа — именно та работа, где строгая типизация и зрелая транзакционность окупаются.

Единственное условие: граница между сервисами должна остаться одна и односторонняя. Как только Python начнёт писать напрямую в пациентские таблицы или Spring Boot начнёт парсить источники — преимущество исчезнет, а издержки двух runtime останутся.

Рекомендация

Разработку не начинать. Осталось ровно одно действие — то самое, которого требует §3.2 самого T3: **proof-of-data на 20–30 реальных препаратах** одной нозологии.

Но сделать его я предлагаю на Австралии, а не на Израиле. Причина не в том, что Австралия — целевой рынок. Причина в том, что при готовом официальном API эта проверка занимает **дни вместо месяцев** и честно отвечает на вопрос, работает ли архитектура: connector → нормализация → сравнение версий → ChangeEvent → уведомление.

После этого тот же конвейер направляется на израильские источники, где вместо API будут ручной сбор и разбор PDF. Архитектура к этому моменту уже доказана, и обсуждать останется только трудоёмкость.

Три действия в порядке приоритета, ни одно не требует писать продукт:

1. **Proof-of-data на PBS API** — 20–30 онкопрепаратов, полный цикл до ChangeEvent. Оценка: дни. Это же измерит и частоту изменений за 24 месяца.
1. **Согласие конкретного онколога-рецензента** — связующее ограничение проекта.
1. **Патентная проверка (FTO)** по патенту США 11 887 738 — единственный риск, способный закрыть проект целиком.

Чего я не проверил

- **Наличие скрытого API у сервисов Минздрава Израиля.** Сайт gov.il вернул 403 на автоматическое обращение. Внутренний API у формы поиска вероятен, но неподтверждён и в любом случае не является публичным контрактом.
- **Лицензионные условия и стоимость NICE syndication** — требуется заявка.
- **Покрывает ли BDPM онкопрепараты больничного применения** — во Франции они часто проходят по отдельному списку («liste en sus»). Не проверял.
- **Реальную полноту PBS API по онкологии** — проверял описание API, а не выгрузку по конкретным препаратам. Это и есть задача proof-of-data.
- **Условия использования всех источников** — правовой режим каждого сайта надо проверять отдельно до автоматического сбора.

Источники

Все ссылки открыты и проверены 6–7 августа 2026 года.

- PBS Australia — новый Schedule Data API и CSV: pbs.gov.au/info/news/2024/12/new-pbs-schedule-data-api-and-api-csv-files
- PBS — спецификация API: info.data.pbs.gov.au/api/open-api-v1-0-0/ · data.pbs.gov.au/document/91327.html
- PBS — страница загрузок: pbs.gov.au/info/browse/download
- Base de données publique des médicaments (ANSM/HAS/UNCAM): base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr · data.gouv.fr/datasets/base-de-donnees-publique-des-medicaments-base-officielle
- Open Medic — базы возмещений (Assurance Maladie): assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/open-medic-base-complete-depenses-medicaments
- NICE — руководство по syndication API: nice.org.uk/corporate/ecd10 · nice.org.uk/reusing-our-content/nice-syndication-api
- NHSBSA — выпуск файлов dm+d через TRUD: nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/nhs-dictionary-medicines-and-devices-dmd/release-dmd-files
- EMA — выгрузка данных о препаратах: ema.europa.eu/node/82422
- data.gov.il — обращение к боевому API (package_search, запрос «תופורת»): data.gov.il/api/3/action/package_search
- Минздрав Израиля — реестр лекарств: gov.il/en/service/israeli-drug-index
- Израильская корзина здоровья — порядок ежегодного обновления: en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Health_Basket
- Отчёт госконтролёра Израиля о расширении корзины: library.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.5/EN/2022.5-203-Sal_Habriut-Taktzir-EN.pdf
- Патент США 11 887 738: image-pubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11887738